

Roleplay Script: "Safe Transfer from OR to PACU"

English Conversation SBAR Season 2 — Safety Communication: I-SBAR Bedside Handover

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. | เคส: Left Total Knee Arthroplasty (TKA) | เวลารวม ~10–15 นาที

เวอร์ชันนี้ปรับจากบทสนทนาที่ทิมคุยกับ ChatGPT ไว้แล้ว (`คยisbar chatgpt.pdf`) — ใช้เคส TKA เดิม
ใส่ชื่อนักแสดงจริงตามที่ทิมตั้งไว้ในสคริปต์ปี 2024 (`Hand over Scrip 5-7-24.doc`)

รายชื่อนักแสดง

บทบาท	ชื่อ
Host	Kornika Kaewsee
CRNA	Supatchaya Chanprasert
Scrub Nurse	Watcharaporn Boonkate
PACU Nurse 1	Nootchanard Inthana
PACU Nurse 2	Narinras Raumtawee
Patient (Mr. Worawit Yosin, 65 y/o)	Worawit Yosin

ปรับชื่อในตารางนี้ได้ตามที่จริง — เนื่อบทใช้ตำแหน่ง (Host/CRNA/PACU Nurse 1/2 ฯลฯ) ไม่ผูกกับชื่อ

SCENE 1 — Introduction (1 นาที)

Host:

Good morning, distinguished judges, ladies and gentlemen.

Today, we would like to present an English Conversation on:

"Safety Communication: I-SBAR Bedside Handover."

>

I-SBAR stands for:

- Identify
- Situation
- Background
- Assessment
- Recommendation

>

I-SBAR is an effective communication tool that improves patient safety and reduces medical errors.

>

Our scenario is a patient undergoing Left Total Knee Arthroplasty, who is being transferred from the Operating Room to the Post-Anesthesia Care Unit (PACU).

>

Let's begin.

SCENE 2 — Patient Arrives at PACU / OR → PACU Handover (5–6 นาที)

(เสียง Monitor ดังเบาๆ — CRNA และ Scrub Nurse เข็นเตียงผู้ป่วยเข้ามา)

CRNA: Good afternoon. I'd like to hand over a patient using the I-SBAR framework.

PACU Nurse 1: Good afternoon. I'm ready to receive the handover.

I — Identify

CRNA:

This is Mr. Worawit Yosin, a 65-year-old male, hospital number [HN-XXXXXX], from the Orthopedic Ward, bed 12. I am the nurse anesthetist who took care of him during the operation.

PACU Nurse 1 (checking the patient's wristband): Thank you. I confirm the patient's name and hospital number match the wristband — Mr. Worawit Yosin.

S — Situation

CRNA:

He has just undergone a Left Total Knee Arthroplasty under spinal anesthesia. The operation was completed without complications.

PACU Nurse 1: Thank you. Please continue.

B — Background

CRNA:

The patient has osteoarthritis of the left knee. He is allergic to Ibuprofen. No history of hypertension, diabetes, or heart disease.

Spinal anesthesia was performed successfully on the first attempt — sensory level achieved was T8.

Before surgery, he received Cefazolin 2 grams and Tranexamic acid 1 gram.

The operation started at 09:05 AM and ended at 12:00 PM.

PACU Nurse 1 (closed-loop): Copy that. Patient allergic to Ibuprofen. Spinal anesthesia level T8. Received Cefazolin and Tranexamic acid.

CRNA: Correct.

A — Assessment

CRNA:

Vital signs remained stable throughout the procedure. Blood pressure ranged from 120 to 140 over 60 to 80 mmHg, heart rate 60 to 80 beats per minute. Estimated blood loss was 10 milliliters, urine output 450 milliliters, and he received 1,300 milliliters of IV fluids.

Current vital signs: BP 128/72, HR 74, SpO₂ 99%. Pain score is 0 out of 10.

PACU Nurse 2 (checking dressing): The surgical dressing is clean and dry. No active bleeding noted.

PACU Nurse 1: Understood.

R — Recommendation

CRNA:

The Cryocuff is still applied and should remain in place until 2 PM. There is one unit of packed red blood cells reserved in the blood bank. The patient should be transferred to Intermediate Ward 5/2 after recovery. Please notify the orthopedic surgeon to perform an adductor canal block for postoperative pain management.

PACU Nurse 1 (closed-loop, repeating back):

Let me repeat: Cryocuff until 2 PM. One unit PRC reserved. Transfer to Intermediate Ward 5/2. Notify orthopedic surgeon for adductor canal block.

CRNA: Correct. Thank you. (Handover complete)

SCENE 3 — PACU Assessment (1–2 นาที)

PACU Nurse 1: Hello, Mr. Worawit. I am your recovery room nurse. How are you feeling right now?

Patient: I feel cold.

PACU Nurse 1: That's normal after surgery. I will place a warming blanket over you. Please let me know if you feel uncomfortable.

(PACU Nurse 2 วัดสัญญาณชีพ)

PACU Nurse 2: Vital signs are stable. Blood pressure 126 over 70. Heart rate 76. Oxygen saturation 99%.

SCENE 4 — Patient Safety Event (2–3 นาที)

Patient: Excuse me, nurse... I feel dizzy.

PACU Nurse 1: Thank you for telling me. Let's assess you immediately.

PACU Nurse 2: Blood pressure is now 95 over 60. Heart rate 88.

PACU Nurse 1: Please elevate the legs and increase IV fluids. Let's reassess in five minutes.

PACU Nurse 2: Understood. Legs elevated and IV fluids increased.

(5 นาทีผ่านไป — เสียง Monitor เปลี่ยนจังหวะกลับมาเป็นปกติ)

PACU Nurse 2: Blood pressure is now 118 over 70. Heart rate 75.

PACU Nurse 1: Excellent. The patient is improving.

SCENE 5 — Recovery (1 นาที)

PACU Nurse 1: Can you move your feet and ankles?

Patient: Yes, I can move them now.

PACU Nurse 1: Good. Do you have any pain?

Patient: Only mild discomfort.

PACU Nurse 1: The orthopedic surgeon will perform an adductor canal block shortly.

SCENE 6 — Closing (1 นาที)

Host:

Today we demonstrated how effective SBAR communication promotes patient safety during patient transfer from the Operating Room to the PACU. Accurate communication helps prevent errors, improves teamwork, and ensures continuity of care.

All Participants Together:

"The right information, to the right person, at the right time, for the right patient."

Everyone: Thank you.

I-SBAR / Checklist (สำหรับ Vera ตรวจสอบ)

- [x] I — Identify ครบ (ชื่อ, อายุ, HN, ward/bed, ผู้ส่งเวรคือใคร + การยืนยันตัวผู้ป่วยด้วย wristband)
- [x] S — Situation ครบ (เหตุการณ์/ผ่าตัดเสร็จไม่มี complication)
- [x] B — Background ครบ (โรคประจำตัว, ภูมิแพ้, anesthesia detail, premedication, เวลาผ่าตัด)
- [x] A — Assessment ครบ (vital signs ระหว่างผ่าตัด + ปัจจุบัน, pain score, wound)

- [x] R — Recommendation ครบ (Cryocuff, PRC reserve, ward transfer, แจ้งแพทย์ทำ block)
- [x] Closed-loop communication — Scene 2 มี 2 จุด (allergy/anesthesia info, recommendation)
- [x] Patient Safety Event — Scene 4 (เรียนศิระชะ → BP ตก → ทีมประเมิน/แก้ไข → ดีขึ้น) แสดง Assessment + Recommendation + Teamwork ชัดเจน
- [x] Safety message ปิดท้าย พร้อมกันทั้งทีม

หมายเหตุการนำเสนอ (เพื่อคะแนนข้อ 2.3 ความน่าสนใจ และข้อ 4 ภาพรวม)

- เปิดฉากด้วยเสียง Monitor + เซ็นเตียงผู้ป่วยเข้ามาจริง ให้กรรมการรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์
- เตรียมอุปกรณ์ประกอบ: เตียง/รถเข็นผู้ป่วย, จอ Monitor จำลอง (แสดงเลข BP/HR เปลี่ยนได้), Foley bag, IV line, Cryocuff
- ใน Scene 4 ปรับเลข BP/HR บนจอ Monitor จำลองให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจริง (95/60 → 118/70) เพิ่ม drama
- ใช้ closed-loop communication (พูดทวนคำสั่ง) ให้ชัดและจังหวะธรรมชาติ — กรรมการมักให้คะแนนส่วนนี้สูง
- ซ้อมจับเวลาจริง 2 รอบ ให้อยู่ในช่วง 10–15 นาที (ตามสคริปต์นี้ประมาณ 11–13 นาที มี buffer)
- จบด้วยทุกคนยืนเรียงหน้าเวที พูด safety message พร้อมกัน แล้ว bow